

Intro:

Petite liste qui met tous les éléments à **ne pas oublier car ses simplets nous lâchent dans la nature sans rien nous donner. Listes non complètes!**

Anamnèse et plaintes courantes selon les spécialités:

- **Anamnèse générale**
- **Gériatrique**
 - ECA
 - Maltraitance
- **Cardio-pneumo-vascu:**
 - Dyspnée
 - Douleur thoracique (avec urgence et psy!)
 - Toux
 - Douleur-rétrosternal (avec gastrologie)
 - Palpitation
 - Oedème de MI
 - Hémoptysie
- **Gastrologie:**
 - Ballonnement
 - Constipation/Diarrhée/incontinence
 - Sang dans les selles
 - Rectorragie
 - Melena
 - Hématochézie
 - Douleur abdominal
 - Nausée/Vomissement
 - Douleur scrotale
 - Hernie
 - Ictère
 - Hématémèse (URG)
 - Adaptation de l'alimentation
- **Palliatif**
 - Adapter les traitements selon les grands symptômes (7)
- **Psychiatrie**
 - HEADSS
 - Anxiété (Trouble anxieux, argoraphobie, trouble panique, TOC)
 - Déficit de l'attention
 - Changement de comportement
 - Trouble alimentaire
 - Boulimie
 - Anorexie
 - Changement d'humeur
 - Dépression
 - Manie

Fichier éditable

- Hyperactivité
- Phobie
- ECA
- Stress aigue/ PTSD
- Evaluation de la capacité de discernement
- Crise suicidaire
- Dépression post-partum/ lien mère enfant

- **Pédiatrie**
 - Peau
 - Gastro
 - Fièvre
 - SDR (bronchiolite, faux croup, pneumonie, croup, apnée du nourrisson)

- **Sexuelle**
 - IST
 - Dysfonction sexuelle
 - Infertilité

- **Urologie:**
 - Anurie, pollakiurie, oligurie polyurie (SSP 63)
 - Incontinence urinaire (SSP77) (DD Neuro DD gyneco)

- **Gynéco**
 - Contraception (SSP66)
 - Dysmanorhé (SSP66)
 - Métrorragie
 - Améhorhée/Ménopause (SSP74)
 - Douleur pelvienne
 - Prolapsus vaginal et uterine
 - Perte vaginale
 - Contraception en urgences

- **Obstétrique** (voir plus bas)

- **Neurologie**
 - Syncope (DD cardio et psy)
 - Instabilité à la marche
 - Tremor, chorée, mouvement, trouble coordination
 - AVC:
 - Vertige (DD ORL)
 - Céphalé/migraine
 - Démence
 - Paralysie/parésie
 - Convulsion
 - Méningisme

- **Ortho**
 - Dorsalgie
 - Fracture(SSP81)
 - Arthralgie
 - Immobilité d'un membre (DD neuro)

- **Rhumatho:**
 - Myalgie
 - Crampes
 - Arthralgie (DD arthrose)
- **Anesthésie :**
 - pré-opératoire
- **Chir:**
 - pré-opératoire
- **Ophtalmo:**
 - Mouvement des yeux inhabituelle (attention neuro!)
 - Diplopie (attention neuro!)
 - Perte de vision, perte de vision fugace
 - Écoulement de l'oeil
 - Strabisme
 - Flash, corps flottant
- **ORL:**
 - Changement de voix
 - Trismus
 - Epistaxis
 - Acouphène
 - Perte d'audition
 - Dysphagie (gastro)
 - Surdit  , perte d'audition
 - Masse dans la sph  re ORL
 - Goitre
- **Dermatologique**
 - Acn  e
 - Perte de cheveux
 - Macule, papule plaque
 - Suspicion de cancer
 - Atteinte des ongles (DD Imuno)
 - Rougeur, ecz  ma
 - L  sions bulleuses
- **H  matologie**
 - Ecchymosis, h  matome, purpura
- **Sant   tropical**
 - D  part/retour de voyage en zone    risque

G  n  raliste (les grandes plaintes):

- Fatigue
- Fl  vres
- Grattage
- Trouble du sommeil
 - Apn  e du sommeil (ronflement)
- Oed  me

Fichier éditable

- Perte de poids ou gain de poids inhabituelle

Suivie ambulatoire:

Station spécial:

- Anamnèse déjà effectuée, faire anamnèse et status ciblé selon ce qui est demandé
exemple:
 - Anamnèse et prise en charge du DBT II déjà fait, ciblé sur le pied diabétique

Suivi ambulatoire

- Suivi d'enfant
 - 2 mois
 - 4 mois
 - 6 mois
 - 9 mois
 - 12 mois
 - Retard de croissance
 - Maltraitance
 - Vaccin
 - Trouble du comportement
 - Retard de développement
- Suivre maladie chronique
 - Suivre d'hypertension
 - Suivre diabète
 - Conseil d'hygiène de vie
 - FR modifiable
 - Autre traitement?
- Changement de la prise en charge (médicaments ou autre)
- Obstétrique:
 - Consultation de suivi:
 - Premier suivi
 - 12 semaines
 - 16 semaines
 - 24 semaines
 - 32 semaines
 - 38 semaines
 - Préparation avant la naissance
 - Désordre hypertensive de la grossesse
 - Pré-éclampsie et HELLP
 - Lactation
 - Droit et condition de travail
 - Complication de la naissance (si fin de grossesse)

Communication:

Breaking bad news

- Cancer

Fichier éditable

- VIH
- Diabète type 1

Décision partagée

- Traitement de statine ?
- Antibiotique pour cystite

Décision thérapeutiques;

Entretien motivationnel

- Tabac
- Addictologie
- Traitement HTA
- Traitement coronarien

Autre

- Discussion des proches aidants
- Patient spécial
- attitude REA

Status:

- ☐ Neurologie
- ☐ Cardiologie
- ☐ Pneumologie
- ☐ Abdominal
- ☐ ORL
 - ☐ Oreille
 - ☐ Nez
 - ☐ Cou
- ☐ Ophtalmo
- ☐ Pédiatrie
 - ☐ Satus du NN
 - ☐ Croissance
 - ☐ PED G
- ☐ Gynécologie
- ☐ Obstétrique
- ☐ Psychiatrie
- ☐ Orthopédie
 - ☐ Coude
 - ☐ Main
 - ☐ Plaies de la main
 - ☐ Epaule

Fichier éditable

- ☐ Poignet
- ☐ Hanche
- ☐ Pied/cheville
- ☐ Genou
- ☐ Rachis
- ☐ gals
- ☐ Dermatologie

Examen complémentaire:

- Interpretation radiologie
 - CT-Scan
 - Rx
 - US
- Interpretation ECG
 - Infarctus
 - Trouble du rythme

Tips:

Lors du status:

- Le faire le plus académique possible
 - Pour l'ABCDE, gueuler votre approche pour que tout le monde comprenne

Pour l'examen complémentaire:

- Vomir les examens complémentaires même les plus absurdes avant le DD

Lors du management, il faut savoir si:

- On hospitalise le patient
- On revoit le patient dans une semaine ou avoir un suivi rapproché
- Est-ce qu'on organise chez un autre spécialiste
- Quel traitement il faut lui donner en urgence et après
- Arrêter les traitements si cela est nécessaire
- PROPHYLAXIE MÉDICAMENTEUSES COMME LA CLEXANE SURTOUT ORTHO OU ALITEMENT PROLONGÉ
- si retour ambulatoire: moyen de retour (bequille?)